



Documento Técnico de la Encuesta Nacional de Experiencia del Usuario en Salud (ENUS 2026)

Ministerio de Salud y Protección Social

2026-08-26

Documento metodológico oficial | ClicSalud — Encuesta Nacional de Experiencia
del Usuario en Salud (ENUS 2026)

Índice general

Presentación	5
Introducción	6
1. Antecedentes	8
1.1. Marco normativo: el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud	8
1.2. Evolución conceptual: de la percepción de calidad a la medición de la experiencia	10
1.3. Primeros antecedentes: 2003-2011	12
1.4. Consolidación de las mediciones del MSPS: 2012-2019 . . .	13
1.4.1. Evolución de la población objetivo	13
1.4.2. Evolución del diseño muestral	15
1.4.3. La medición de 2017	19
1.5. Continuidad y transformaciones de las mediciones del MSPS: 2018-2025	20
1.5.1. Comparación de las mediciones 2018-2025	21
1.5.2. 2018 — Ranking de Satisfacción EPS	24
1.5.3. 2020 — Estudio Nacional de Evaluación de los Servicios de las EPS	24
1.5.4. 2022 — Encuesta Nacional de Satisfacción de los Usuarios frente a los Servicios de las EPS	25
1.5.5. 2023 — Encuesta con énfasis en Atención Primaria en Salud	25

1.5.6. 2024-2025 — Mediciones inmediatamente anteriores a ENUS 2026	26
1.6. Aprendizajes de las mediciones históricas	26
1.6.1. Cambios en la población incluida	27
1.6.2. Cambios en la forma de seleccionar a los usuarios	27
1.6.3. Cambios en los temas y preguntas	28
1.6.4. El cambio de modalidad de recolección en 2020	28
1.7. ENUS 2026 como nueva línea base de medición	29
1.8. Referentes internacionales para la medición de la experiencia del usuario en salud	30
1.8.1. CAHPS: medición estandarizada de la experiencia del paciente	30
1.8.2. OMS: capacidad de respuesta de los sistemas de salud	31
1.8.3. OCDE-PaRIS: experiencias y resultados reportados por los pacientes	32
1.8.4. Elementos comunes de los referentes internacionales	32
2. Objetivo de la ENUS 2026	34
2.1. Objetivo general	34
2.2. Objetivos específicos	34
3. Alcance de la operación estadística	36
3.1. Fenómenos objeto de medición	36
3.2. Población objetivo	37
3.3. Unidad de observación	38
3.4. Cobertura territorial	38
3.5. Cobertura temporal y periodo de referencia	39
3.6. Servicios de salud objeto de medición	39
3.7. Dominios de análisis	39
3.8. Límites del alcance	40

4. Diseño muestral	41
4.1. Esquema de cuotas y composición de la muestra	42
4.2. Determinación del tamaño de muestra	43
4.2.1. Cálculo de referencia	44
4.2.2. Ajuste por efecto de diseño	45
4.2.3. Corrección por población finita	45
4.2.4. Ajuste operativo y meta de captación	46
4.2.5. Parámetros adoptados	46
4.2.6. Tamaño adoptado: asignación por región	47
4.2.7. Asignación del tamaño de muestra por cuotas	48
4.2.8. Resultado agregado por región y régimen	50
4.2.9. Composición agregada de las cuotas	50
4.2.10. Papel de las EPS, IPS y gestores en la captación	51
4.2.11. Diferenciación conceptual para el análisis	52
4.2.12. Alcance de los análisis por dominio y estructura de la participación	54
Referencias	56

Presentación

El presente documento constituye el Documento Técnico de la Encuesta Nacional de Experiencia del Usuario en Salud (ENUS 2026), operación estadística del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) orientada a la medición de la experiencia de los usuarios frente a los servicios de salud.

El documento ha sido elaborado por la Oficina de Calidad del Ministerio de Salud y Protección Social y tiene como propósito establecer y documentar los aspectos técnicos y metodológicos que sustentan el diseño, ejecución, procesamiento, análisis y generación de resultados de la operación estadística.

En este sentido, constituye el marco de referencia para la revisión técnica, validación institucional, implementación y documentación de la ENUS 2026, procurando que las diferentes etapas de la operación se desarrollen bajo criterios de coherencia metodológica, trazabilidad y reproducibilidad.

El documento presenta de manera integrada los elementos que sustentan la operación estadística, incluyendo sus objetivos, alcance, diseño estadístico, diseño de la recolección, procesamiento de la información, estrategias de estimación y validación, así como los mecanismos previstos para el control de calidad y la generación de los productos estadísticos.

La documentación se estructura de manera que permita identificar la relación entre los objetivos de la operación, las necesidades de información, los instrumentos de recolección, las variables e indicadores derivados y los procedimientos estadísticos utilizados para la producción de resultados.

Introducción

La medición de la experiencia y la satisfacción de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) cuenta con antecedentes en Colombia que incluyen ejercicios desarrollados por la Defensoría del Pueblo y posteriores mediciones institucionalizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Estas experiencias han permitido generar evidencia sobre diferentes dimensiones de la relación de los usuarios con los servicios de salud, entre ellas el acceso, la oportunidad, el trato y la satisfacción (Ministerio de Salud y Protección Social 2017, 2020, 2022, 2023; Matajira Gaitán et al. 2018). La *Encuesta Nacional de Experiencia del Usuario en Salud (ENUS 2026)* se desarrolla en continuidad con estos antecedentes y busca fortalecer la generación sistemática de información sobre la experiencia de los usuarios con los servicios de salud que reciben.

La experiencia reportada por los usuarios constituye una fuente de información complementaria a los registros administrativos y a otros mecanismos de seguimiento del sistema de salud. Su medición permite identificar diferencias en la forma en que los usuarios acceden a los servicios, reciben atención, interactúan con las instituciones y valoran distintos aspectos del proceso de atención. En este sentido, la información obtenida mediante la ENUS constituye un insumo para el seguimiento y análisis de las condiciones de atención y para apoyar los procesos de evaluación y toma de decisiones en el sector salud.

La ENUS 2026 se estructura a partir de un cuestionario diseñado para recoger información sobre las diferentes dimensiones de la experiencia de los usuarios. La aplicación del instrumento se realiza mediante *ClicSalud*, herramienta de recolección en la que se implementan las preguntas, validaciones y reglas de navegación. La secuencia de aplicación se encuentra definida mediante un árbol de decisión que establece las condiciones de entrada, los saltos y las rutas que debe seguir cada participante de acuerdo con sus características y respuestas. Esta estructura permite que no todos los participantes respondan necesariamente el mismo conjunto de preguntas y que la información obtenida corresponda a la ruta aplicable a cada caso.

La captación de participantes se desarrolla mediante un mecanismo de *muestreo por cuotas* (Kish 1965; Elliott y Valliant 2017), en el que las EPS e IPS participantes actúan como canales institucionales de promoción y captación de usuarios. La clasificación de los participantes y el control de las cuotas se realizan de acuerdo con las variables y categorías definidas para la operación. Este procedimiento determina la composición objetivo de la muestra y constituye un componente central del diseño de la encuesta, por lo que sus características, reglas de asignación y mecanismos de control se documentan de manera específica.

Una vez recolectada y validada la información, se conforma la base analítica sobre la cual se aplican los procedimientos de ponderación y *calibración por entropía* (Deville y Särndal 1992; Cressie y Read 1984). Estos procedimientos permiten incorporar información auxiliar y ajustar los pesos de las observaciones de acuerdo con los totales de referencia definidos para la operación. A partir de los pesos calibrados se obtienen los estimadores de los indicadores de interés y se aplican los procedimientos establecidos para evaluar su incertidumbre (Rao y Wu 1988; Efron y Tibshirani 1993) y calidad estadística.

El presente *Documento Metodológico* describe de manera integrada los elementos que sustentan la ENUS 2026: la población objetivo y las unidades de observación, el mecanismo de captación y clasificación de los participantes, y el diseño y control de las cuotas. Documenta, además, la estructura y aplicación del cuestionario y el árbol de decisión que determina sus rutas; el procesamiento y validación de la información recolectada; la construcción y calibración de los pesos; y la estimación de los indicadores junto con los procedimientos para evaluar su incertidumbre y calidad.

La organización del documento sigue la secuencia metodológica de la operación. Los primeros capítulos presentan la identidad y caracterización de la ENUS 2026, establecen su marco general y describen la población objetivo, el diseño de la encuesta, el mecanismo de captación, el instrumento de recolección y la estructura lógica del cuestionario. Los capítulos centrales desarrollan los procedimientos de procesamiento, ponderación, calibración y estimación, así como la metodología para evaluar la incertidumbre y la calidad estadística de los resultados. El documento cierra con las principales limitaciones de la operación y los anexos técnicos que detallan el cuestionario, el árbol de decisión, las cuotas, los indicadores y las matrices de trazabilidad.

En conjunto, el documento constituye el referente metodológico para comprender cómo se estructura la ENUS 2026, cómo se recolecta y procesa la información, y cómo esta se transforma en los resultados estadísticos de la operación.

Capítulo 1

Antecedentes

Este capítulo tiene tres propósitos: presentar la evolución de las mediciones sobre la percepción de calidad, la satisfacción y la experiencia de los usuarios del sistema de salud colombiano entre 2005 y 2025; identificar los principales antecedentes nacionales e internacionales que sirven de referencia para la ENUS 2026; y recoger los principales aprendizajes derivados de estas experiencias.

Estos antecedentes sirven como contexto para el diseño de la ENUS 2026, pero no definen por sí mismos las decisiones metodológicas de la encuesta. Los aspectos relacionados con el diseño muestral, el instrumento, el procesamiento, la ponderación y la estimación se presentan en los capítulos correspondientes.

Para la elaboración de este capítulo se revisaron los documentos originales de las principales mediciones realizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, así como las fuentes utilizadas para los antecedentes nacionales e internacionales. Cuando alguna información no pudo ser comprobada directamente en las fuentes disponibles, se señala para su posterior verificación.

1.1 Marco normativo: el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud

La medición de la experiencia y la satisfacción de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) no es una iniciativa aislada: se inscribe en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud (SOGCS), que constituye el marco reglamentario bajo el cual

el sector salud genera, mantiene y mejora la calidad de los servicios. El SOGCS fue establecido originalmente mediante el Decreto 1011 de 2006 (Ministerio de la Protección Social 2006) y sus disposiciones fueron posteriormente compiladas —sin modificación sustantiva de su contenido— en el Decreto 780 de 2016, Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, que hoy constituye la norma reglamentaria vigente en la materia (Ministerio de Salud y Protección Social 2016a). Por esta razón, las referencias normativas de este documento se hacen al Decreto 780 de 2016, señalando cuando corresponda su origen en el Decreto 1011 de 2006.

De acuerdo con el Decreto 780 de 2016, las acciones del SOGCS se orientan al mejoramiento de los resultados de la atención en salud centrados en el usuario, superando la verificación aislada de la existencia de estructuras o de la documentación de procesos, los cuales constituyen únicamente prerrequisitos para alcanzar dichos resultados. Para efectos de evaluar y mejorar la calidad de la atención, la norma define cinco características esenciales: accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad. Dos de ellas resultan directamente constitutivas del objeto de medición de ENUS 2026. La accesibilidad se define como la posibilidad que tiene el usuario de utilizar los servicios de salud que le garantiza el SGSSS; la oportunidad, como la posibilidad de obtener los servicios requeridos sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud. Ambas dimensiones son retomadas explícitamente por el marco conceptual de este documento para definir la experiencia del usuario (véase la Sección 3.1).

Estructuralmente, el SOGCS se articula en cuatro componentes: el Sistema Único de Habilitación, la Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud, el Sistema Único de Acreditación y el Sistema de Información para la Calidad (SIC). Este último es el componente de anclaje directo de ENUS 2026, en tanto define los mecanismos mediante los cuales el sistema produce, reporta y difunde información sobre la calidad de los servicios desde la perspectiva del usuario. La Resolución 256 de 2016 desarrolló este componente al establecer las disposiciones del SIC y definir el conjunto de indicadores de monitoreo de la calidad, bajo un enfoque orientado al mejoramiento continuo y al impacto sobre los usuarios (Ministerio de Salud y Protección Social 2016c). Es en este mismo componente donde se enmarcan las mediciones institucionales previas del Ministerio —incluidas las encuestas de evaluación de los servicios de las EPS, según lo declaran expresamente sus respectivos informes metodológicos (Ministerio de Salud y Protección Social 2017, 2020)—, lo que permite leer ENUS 2026 como continuidad y no como ruptura respecto de la serie de mediciones anteriores descritas en este capítulo.

Sobre esa base normativa acumulada, la medición de la satisfacción y de las dimensiones asociadas a la interacción de las personas con el sistema de salud ha operado durante casi dos décadas como mecanismo regular

de seguimiento de la calidad. Estas mediciones constituyen el antecedente institucional de una ampliación conceptual de mayor alcance: la incorporación, junto a la medición de satisfacción —construida sobre juicios evaluativos globales del usuario—, de una medición de experiencia del usuario, que documenta ocurrencias concretas y verificables en dimensiones como el acceso, la oportunidad, la continuidad, el trato recibido y la resolución efectiva de la necesidad en salud.

Esta evolución se consolida formalmente con la Resolución 1642 de 2026, que establece lineamientos para la Carta de Derechos y Deberes de las personas afiliadas al SGSSS y adopta la Encuesta Nacional de Experiencia del Usuario en Salud (ENUS) como instrumento oficial para la medición de la experiencia del usuario (Ministerio de Salud y Protección Social 2026). Dicha resolución constituye el acto administrativo que confiere a ENUS 2026 su carácter de operación estadística institucional y define su alcance dentro del SIC.

En síntesis, el marco normativo de ENUS 2026 opera en tres niveles jerárquicos y complementarios: el SOGCS (Decreto 780 de 2016, que compila el Decreto 1011 de 2006) aporta el marco general de calidad y el mandato de orientación al usuario, junto con las definiciones de accesibilidad y oportunidad que la encuesta operacionaliza; el Sistema de Información para la Calidad (Resolución 256 de 2016) establece los mecanismos de monitoreo, los indicadores y las obligaciones de reporte; y la Resolución 1642 de 2026 adopta la ENUS como el instrumento específico mediante el cual se materializa la medición de la experiencia del usuario en salud. Este encadenamiento normativo es el fundamento institucional que sostiene la existencia, la periodicidad y la exigibilidad de las mediciones de experiencia del usuario en el sistema de salud colombiano.

1.2 Evolución conceptual: de la percepción de calidad a la medición de la experiencia

Las mediciones realizadas en Colombia a lo largo del período revisado no han abordado necesariamente el mismo objeto de medición que la ENUS 2026. Se observa una evolución progresiva desde mediciones centradas en la percepción de la calidad y la satisfacción hacia un enfoque que busca caracterizar de manera más amplia la experiencia de las personas durante su interacción con los servicios de salud.

Esta evolución puede entenderse a partir de tres enfoques relacionados, pero conceptualmente diferenciables:

1. **Percepción de calidad.** Las mediciones asociadas con PECASUSS se orientaron a conocer la valoración que los usuarios realizaban sobre

la calidad de los servicios recibidos (Ministerio de la Protección Social 2008). Este enfoque constituye uno de los antecedentes de la medición de la calidad desde la perspectiva de los usuarios en Colombia.

2. **Satisfacción.** Las mediciones desarrolladas posteriormente por la Defensoría del Pueblo y, de manera sistemática, por el Ministerio de Salud y Protección Social, incorporaron la satisfacción como una medida de valoración de los usuarios respecto de los servicios y de las entidades responsables de su atención (Defensoría del Pueblo de Colombia 2009; Ministerio de Salud y Protección Social 2017, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025; Matajira Gaitán et al. 2018). Estas mediciones permitieron realizar seguimiento a la percepción de los usuarios y generar información para el monitoreo de la calidad de los servicios.
3. **Satisfacción y experiencia del usuario.** La ENUS 2026 mide ambos fenómenos de manera complementaria: una valoración global de satisfacción, en continuidad con la serie histórica, y un conjunto de dimensiones específicas de experiencia —hechos concretos de la interacción de las personas con el sistema y los servicios de salud, distintos de esa valoración global—. La definición de cada concepto y las dimensiones específicas de experiencia se desarrollan en el marco conceptual de este documento (3.1).

Los referentes internacionales contribuyen a esta evolución conceptual. Instrumentos como CAHPS, el enfoque de *responsiveness* desarrollado por la Organización Mundial de la Salud y el programa PaRIS de la OECD muestran diferentes formas de medir aspectos de la atención desde la perspectiva de las personas que utilizan los servicios. Estos referentes incorporan dimensiones específicas de la interacción con los servicios y permiten avanzar desde una valoración general hacia mediciones más desagregadas de la experiencia.

En este documento se conserva la terminología utilizada en las fuentes originales. Por esta razón, las mediciones anteriores se presentan como mediciones de percepción de calidad o satisfacción cuando ese es el concepto utilizado por sus respectivos instrumentos, y no se homologan retrospectivamente como mediciones de experiencia del usuario.

Esta precisión es importante porque algunos instrumentos anteriores incorporaron el término “experiencia” en determinadas preguntas o indicadores. Por ejemplo, documentos del ciclo de mediciones del Ministerio de Salud y Protección Social utilizan expresiones relacionadas con la experiencia global de los usuarios (Ministerio de Salud y Protección Social 2017, 2023). Sin embargo, el uso del término en una pregunta particular no implica necesariamente que toda la operación haya tenido como objeto una medición multidimensional de la experiencia del usuario.

En este sentido, los antecedentes presentados en este capítulo no deben interpretarse como una serie de mediciones homogéneas del mismo indicador. Constituyen, más bien, el proceso mediante el cual el sistema de salud colombiano ha desarrollado diferentes mecanismos para conocer la percepción, satisfacción y experiencia de los usuarios. La ENUS 2026 se desarrolla sobre este recorrido y establece la satisfacción y la experiencia del usuario como objetos explícitos y complementarios de medición, de acuerdo con el marco conceptual y normativo que se presenta en los capítulos siguientes.

1.3 Primeros antecedentes: 2003-2011

Entre los primeros antecedentes identificados se encuentran las evaluaciones realizadas por la *Defensoría del Pueblo* y el desarrollo del instrumento *PECASUSS (Percepción de Calidad según Usuarios de Servicios de Salud)*. Estas experiencias constituyen antecedentes importantes para la posterior incorporación de mediciones sistemáticas de la percepción de los usuarios sobre la calidad de los servicios de salud.

Defensoría del Pueblo. En los documentos del Ministerio de Salud y Protección Social revisados para este capítulo se menciona una evaluación de los servicios de las EPS desde la perspectiva de los usuarios, atribuida a la Defensoría del Pueblo y correspondiente al año 2005 (Ministerio de Salud y Protección Social 2017, 2020). Sin embargo, no fue posible localizar ni validar la fuente primaria de esta evaluación; por tanto, se presenta únicamente como un antecedente mencionado en la documentación institucional, sin atribuirle un alcance o contenido específico.

El entonces Ministerio de la Protección Social desarrolló el instrumento *PECASUSS* para evaluar la percepción de los usuarios sobre la calidad de los servicios en el marco del Programa de Reestructuración de Redes de Servicios de Salud (Ministerio de la Protección Social 2008). De acuerdo con los antecedentes documentados por el Ministerio, el instrumento fue aplicado en una medición de línea de base y una medición de seguimiento, correspondientes a 2006 y 2008, respectivamente (Ministerio de Salud y Protección Social 2017, 2020).

A diferencia de las evaluaciones de satisfacción que se desarrollarían posteriormente, *PECASUSS* se centró en la **percepción de la calidad de los servicios** y estuvo dirigido a las instituciones intervenidas por el programa. Por tanto, constituye un antecedente relevante de la medición de la calidad desde la perspectiva de los usuarios, aunque su alcance y objeto de medición fueron diferentes a los de las encuestas posteriores del Ministerio.

1.4 Consolidación de las mediciones del MSPS: 2012-2019

A partir de 2012 el MSPS institucionalizó una medición anual de la satisfacción de los usuarios, inscrita en el **Sistema de Información para la Calidad (SIC)**, a diferencia de los ejercicios previos de la Defensoría del Pueblo (2005) y de PECASUSS (2006 y 2008), desarrollados antes de la creación del SIC. La serie comprende las mediciones realizadas entre 2012 y 2019 (Ministerio de Salud y Protección Social 2017, 2020).

La continuidad institucional de esta serie no implica que sus características metodológicas hayan permanecido constantes. Durante el período se presentan cambios en la población objetivo, los criterios de inclusión y exclusión, los marcos muestrales, las unidades de estratificación y los criterios utilizados para determinar el tamaño y la precisión de las muestras. Estas diferencias son relevantes para interpretar la evolución de los resultados y para establecer comparaciones con ENUS 2026.

1.4.1 Evolución de la población objetivo

Año	Población objetivo declarada	Periodo de referencia	Exclusiones	Muestra efectiva	Fuente
2012	No disponible	—	—	—	—
2013	No disponible	—	—	—	—
2014	Ciudadanos usuarios de servicios de las EPS, solo población mayor de 18 años	Últimos 6 meses	Regímenes especiales y exentos	20.361 encuestas efectivas, en 85 municipios de 32 departamentos y el Distrito Capital	Ministerio de Salud y Protección Social (2016b)

Año	Población objetivo declarada	Periodo de referencia	Exclusiones	Muestra efectiva	Fuente
2015	Ciudadanos usuarios de servicios de las EPS, incluidos menores de edad	Últimos 6 meses	Regímenes especiales (FFMM, Policía, Ecope-trol) y exentos (universidades públicas)	29.761 encuestas efectivas (54.852 contactos), en 73 municipios de 32 departamentos y el Distrito Capital	Consultores en In-formación mé-trika S.A.S. (2015)
2016	Afiliados al SGSSS con uso de servicio en 6 meses previos; excluye regímenes especiales, medicina prepagada y planes complementarios	Últimos 6 meses	Regímenes especiales; medicina prepa-gada, plan comple-mentario	26.502 encuestas efectivas (81.049 contactos), en 95 municipios de 32 departamentos y el Distrito Capital	Ministerio de Sa-lud y Pro-tec-ción So-cial (2016b)
2017	Afiliados al SGSSS que usaron servicios de su EPS, todas las edades , urbano y rural (centros poblados)	Últimos 6 meses	Regímenes especiales y exen-tos; medi-cina prepa-gada, plan comple-mentario y seguro privado	24.586 encuestas efectivas, en 95 municipios de 32 departamentos y el Distrito Capital	Ministerio de Sa-lud y Pro-tec-ción So-cial (2017)
2018-2019	No disponible	—	—	—	—

La población incluida en las mediciones no fue exactamente la misma durante todo el periodo. Se identifican dos cambios importantes, ambos documentados en la sección de antecedentes de la encuesta técnica de 2016, que compara explícitamente las tres ediciones (Ministerio de Salud y Protección Social 2016b).

- *La incorporación de menores de edad en 2015.* Hasta 2014, las encuestas consideraban únicamente a las personas mayores de 18 años. A partir de 2015 se incluyeron también los menores de edad; en 2016 la encuesta también cubrió a toda la población, sin restricción de edad (Ministerio de Salud y Protección Social 2016b). Este cambio amplió de manera importante el número de personas que podían participar en la encuesta: el universo de estudio pasó de 11.425.380 personas en 2014 a 16.555.627 en 2015 (Consultores en Información Infométrika S.A.S. 2015). Por esta razón, las diferencias observadas entre estos dos años no pueden interpretarse únicamente como cambios en la satisfacción de los usuarios, ya que también cambió el grupo de personas al que se referían los resultados —advertencia que hacen explícitamente tanto el informe de 2014-2015 como el propio informe de 2016 (Consultores en Información Infométrika S.A.S. 2015; Ministerio de Salud y Protección Social 2016b).
- *Los cambios en las personas excluidas de la encuesta.* En las ediciones de 2014 y 2016 se excluyeron los afiliados a regímenes especiales y exentos, y a partir de 2017 se agregaron exclusiones relacionadas con quienes contaban con medicina prepagada, planes complementarios o seguros privados de salud (Ministerio de Salud y Protección Social 2016b, 2017). Estos cambios hicieron que el grupo de personas al que se referían los resultados no fuera exactamente el mismo en todos los años.

Por estas razones, los resultados de las encuestas realizadas entre 2012 y 2019 no deben interpretarse como una serie completamente homogénea. Al compararlos con la ENUS 2026 será necesario tener en cuenta quiénes fueron incluidos en cada medición y bajo qué condiciones se realizaron las encuestas.

1.4.2 Evolución del diseño muestral

Los cambios en la población objetivo estuvieron acompañados por modificaciones en el diseño muestral. Aunque las **EPS permanecieron como unidad de análisis**, la unidad de estratificación y la organización de las etapas de selección cambiaron entre las diferentes ediciones.

Año	Diseño declarado	Unidad de estratificación	Etapas y unidades de muestreo	Marco muestral	Criterio de tamaño y precisión	Fuente
2012	No disponible	—	—	—	—	—
2013	No disponible	—	—	—	—	—
2014	Probabilístico	—	—	—	—	—
2015	de conglomerados	declarada	Unidades de selección: secciones cartográficas DANE. Unidades de análisis: cada EPS	Tres marcos completos: men- tarios: dos de áreas (DANE 2005, actualización 2012, y catastro) y uno de lista, provisto por el MSPS, para EPS de muy baja participación	Variable trazadora tipo proporción con $P = 50\%$; error máximo esperado inferior al 5 % para proporciones de mínimo 50 %	Consultores en formación In-fo-mé-tri-ka S.A.S. (2015)



Año	Diseño declarado	Unidad de estratificación	Etapas y unidades de muestreo	Marco muestral	Criterio de tamaño y precisión	Fuente
2016	Probabilístico, multi-etápico, estratificado y de conglomerados (mismo diseño que 2017)	Grupos de municipios según categoría DNP (tres estratos)	1. ^a municipios (32 capitales de inclusión forzosa, 23 de categoría 1-5 DNP y 40 de categoría 6, estos dos últimos con probabilidad proporcional al tamaño); 2. ^a manzanas; 3. ^a personas	Lista de municipios con caracterización; áreas de manzanas sobre cartografía censal DANE; lista de miembros del hogar levantada en campo	26.502 encuestas efectivas (81.049 contactos), 18 % sobre la meta fijada por el Ministerio	Ministerio de Salud y Protección Social (2016b)

Año	Diseño declarado	Unidad de estratificación	Etapas y unidades de muestreo	Marco muestral	Criterio de tamaño y precisión	Fuente
2017	Probabilístico multi-etápico, estratificado y de conglomerados	Grupos de municipios según categoría DNP (tres estratos)	1. ^a municipios; 2. ^a manzanas (proporcional a hogares); 3. ^a personas. Unidad de análisis: EPS	Lista de municipios con caracterización; áreas de manzanas sobre cartografía censal DANE (Censo 2005, actualización 2012); lista de miembros del hogar levantada en campo	Error relativo inferior al 5 % para proporciones superiores al 20 %, nacional y por nivel de desagregación	Ministerio de Salud y Protección Social (2017)
2018	No disponible	—	—	—	—	—
2019	No disponible	—	—	—	—	—

La comparación de las ediciones documentadas muestra tres cambios importantes en la forma en que se organizaron las encuestas.

- *El diseño de 2016 fue heredado, no reinventado, por la edición 2017.* Las ediciones 2016 y 2017 comparten exactamente los mismos tres

estratos DNP y los mismos 95 municipios como unidades primarias de muestreo (Ministerio de Salud y Protección Social 2016b, 2017), lo que indica que la arquitectura de estratificación territorial se fijó en 2016 y se mantuvo sin cambios en la edición siguiente. En ambas, la selección comenzó por los municipios, agrupados según su categoría DNP, y posteriormente se seleccionaron manzanas y personas dentro de esos territorios.

- *También cambió el criterio para determinar el tamaño y la precisión de las muestras.* En las mediciones de 2014-2015 se utilizó un criterio basado en una proporción esperada del 50 % y un error máximo inferior al 5 % (Consultores en Información Infométrika S.A.S. 2015). En 2017 se estableció un error relativo inferior al 5 % para proporciones superiores al 20 % (Ministerio de Salud y Protección Social 2017). Estos criterios no son directamente comparables, por lo que las diferencias en la precisión de los resultados entre años deben interpretarse con cautela. La fuente de 2016 no documenta un criterio de precisión comparable a los anteriores, más allá de reportar el porcentaje de encuestas logradas sobre la meta fijada (Ministerio de Salud y Protección Social 2016b).
- *El marco de área se mantuvo basado en información censal de 2005.* Tanto las mediciones de 2014-2015 como la de 2017 utilizaron cartografía del DANE correspondiente al Censo General 2005, actualizada a la vigencia 2012 (Consultores en Información Infométrika S.A.S. 2015; Ministerio de Salud y Protección Social 2017). Esto significa que, aunque las encuestas se realizaron varios años después del censo, la selección de los hogares partía de esa estructura territorial. Esta característica es importante al analizar la cobertura de las encuestas y la forma en que representaban a la población en cada momento.

1.4.3 La medición de 2017

La **Encuesta Nacional de Evaluación de los Servicios de las EPS 2017** (Ministerio de Salud y Protección Social 2017) constituye un punto importante dentro de esta evolución. Se enmarca explícitamente en el SOGCS y dentro del SIC, en línea con el marco normativo de la Sección 1.1, y adoptó un diseño **probabilístico, multietápico, estratificado y de conglomerados**, con tres etapas anidadas:

- *Primera etapa — municipios.* El marco estuvo constituido por una lista de los municipios del país con información de caracterización, entre ella cantidad de afiliados, clasificación DNP y número de EPS con afiliados en el municipio. El territorio se estratificó en tres grupos según la categoría municipal DNP: 32 municipios capitales de departamento, incluida Bogotá D.C.; 23 municipios de categoría 1 a 5; y 40

municipios de categoría 6. En total, 95 municipios constituyeron las unidades primarias de muestreo.

- *Segunda etapa — manzanas.* Dentro de cada municipio seleccionado se realizó la selección de manzanas con probabilidad proporcional a la cantidad de hogares. El marco de áreas se construyó sobre la cartografía censal del DANE, con los polígonos de sector, sección y manzana y la información de viviendas, hogares y personas del Censo General 2005, actualizada a la vigencia 2012. En las áreas rurales el marco correspondió a las manzanas urbanas de los centros poblados de los municipios seleccionados.
- *Tercera etapa — personas.* El marco estuvo constituido por una lista de los miembros del hogar construida durante la recolección. Sobre este listado se seleccionó **una persona** que hubiera utilizado los servicios de salud en los seis meses previos. Para los menores de edad se solicitó como informante al adulto que acompañaba al menor al servicio de salud.

Las unidades de análisis fueron las EPS y los niveles de desagregación previstos correspondieron al régimen, la EPS y el departamento. El operativo se realizó entre julio y agosto de 2017, mediante entrevista personal cara a cara con un cuestionario estructurado de 60 preguntas organizadas en 18 capítulos. Se obtuvo una muestra efectiva de 24.586 encuestas en 95 municipios de los 32 departamentos y el Distrito Capital, a partir de la cual los resultados se infirieron a una población estimada de 16.815.482 usuarios. La precisión declarada correspondió a un error relativo inferior al 5 % para proporciones superiores al 20 %.

El cuestionario articuló siete ejes temáticos: **satisfacción, oportunidad, acceso, trato digno, respuesta, caracterización del usuario y corresponsabilidad del usuario** (Ministerio de Salud y Protección Social 2017). Varios de estos temas reaparecen, con una definición propia, entre las dimensiones de experiencia del usuario del marco conceptual de este documento (3.1). La encuesta de 2017 constituye así un antecedente importante de la incorporación progresiva de dimensiones relacionadas con la interacción de los usuarios con los servicios de salud, aunque su objeto principal continuaba siendo la evaluación de los servicios de las EPS y la satisfacción de sus usuarios.

1.5 Continuidad y transformaciones de las mediciones del MSPS: 2018-2025

Entre 2018 y 2025 las mediciones del MSPS mantuvieron la evaluación de la satisfacción de los usuarios como eje principal, pero incorporaron cam-

bios en los instrumentos, los temas abordados y las formas de recolección. En este periodo se observan además dos momentos particulares: la modificación del operativo durante la pandemia de COVID-19 en 2020 y el retorno a la recolección presencial en 2022. Las mediciones de 2023, 2024 y 2025 muestran la continuidad de la serie hasta los años inmediatamente anteriores a la ENUS 2026.

1.5.1 Comparación de las mediciones 2018-2025

Año	Medición	Enfoque principal	Recolección / diseño	Muestra	Principales características
2018	Ranking de Satisfacción EPS	Satisfacción, oportunidad y trámites	Análisis secundario de la información de 2017	Información de 2017	51 indicadores agrupados en tres dimensiones: oportunidad, satisfacción y trámites. Incorporación de <i>boots-trapping</i> para comparar diferencias entre EPS

Año	Medición	Enfoque principal	Recolección / diseño	Muestra	Principales características
2020	Estudio Nacional de Evaluación de los Servicios de las EPS	Evaluación de servicios y satisfacción	Entrevista telefónica; muestreo de lista	18.630 personas, 36 EPS	Cambio del muestreo de áreas a muestreo de lista. Ampliación de 157 a 541 municipios por las dificultades de respuesta telefónica. Inclusión de módulo sobre COVID-19
2022	Encuesta Nacional de Satisfacción de los Usuarios frente a los Servicios de las EPS	Satisfacción, acceso, recomendación y trámites	Entrevista presencial; selección aleatoria de barrios y manzanas y barrido de hogares	18.360 encuestas	Retorno a la recolección presencial. Resultados expandidos a 42.897.182 personas

Año	Medición	Enfoque principal	Recolección / diseño	Muestra	Principales características
2023	Encuesta con énfasis en Atención Primaria en Salud	Satisfacción y atención primaria en salud	Probabilístico, estratificado, de conglomerados y trietápico; entrevista presencial	14.845 encuestas válidas (mín. contractual 12.096)	Selección de municipios, sectores censales y personas. Desagregación en seis macrorregiones. Instrumento de aproximadamente 75 preguntas
2024	Encuesta para Evaluar la Satisfacción de los Usuarios del Sistema de Salud Colombiano	Satisfacción de los usuarios	Diseño no documentado en los antecedentes revisados	—	Continuidad de la medición de satisfacción. El título oficial no incorpora el énfasis en atención primaria de 2023

Año	Medición	Enfoque principal	Recolección / diseño	Muestra	Principales características
2025	Encuesta para Evaluar la Satisfacción de los Usuarios del Sistema de Salud Colombiano	Satisfacción de los usuarios	Diseño no documentado en los antecedentes revisados	18.639 usuarios	Levantamiento entre septiembre y diciembre. Cobertura en seis regiones del sistema de salud

1.5.2 2018 --- Ranking de Satisfacción EPS

La edición de 2018 (Matajira Gaitán et al. 2018) no correspondió a una nueva encuesta, sino a un análisis de la información obtenida en 2017. El cambio principal estuvo en la forma de organizar y presentar los resultados: la dimensión de acceso fue sustituida por la dimensión de trámites y se construyó un ranking a partir de 51 indicadores agrupados en tres dimensiones con igual ponderación: oportunidad (33,3 %), satisfacción (33,3 %) y trámites (33,3 %).

Para comparar los resultados entre EPS se utilizó un procedimiento de remuestreo (*bootstrapping*) que replicó el ejercicio 1.000 veces y permitió establecer un umbral para determinar cuándo las diferencias entre los puntajes podían considerarse estadísticamente significativas (Matajira Gaitán et al. 2018).

1.5.3 2020 --- Estudio Nacional de Evaluación de los Servicios de las EPS

La medición de 2020 (Ministerio de Salud y Protección Social 2020) estuvo marcada por las condiciones generadas por la pandemia de COVID-19. La encuesta, que tradicionalmente se realizaba mediante entrevistas presenciales, pasó a realizarse por vía telefónica. Este cambio estuvo acompañado por una modificación del diseño muestral: se pasó de un muestreo de áreas a un muestreo de lista (Ministerio de Salud y Protección Social 2020).

Las dificultades para obtener las entrevistas previstas llevaron a ampliar la cobertura inicialmente establecida de 157 a 541 municipios. Finalmente

se realizaron 18.630 encuestas a usuarios de 36 EPS en los 33 departamentos (Ministerio de Salud y Protección Social 2020). La encuesta incorporó además un módulo específico sobre diagnóstico y atención relacionados con COVID-19.

El cambio en la modalidad de recolección constituye uno de los principales elementos metodológicos de esta edición, ya que modifica la forma de contacto con los usuarios y el marco utilizado para seleccionarlos.

1.5.4 2022 --- Encuesta Nacional de Satisfacción de los Usuarios frente a los Servicios de las EPS

La medición de 2022 (Ministerio de Salud y Protección Social 2022) retomó la recolección presencial. La selección se realizó mediante una combinación de selección aleatoria de barrios y manzanas, apoyada en cartografía, y un barrido de hogares dentro de las manzanas seleccionadas. Cuando no se alcanzaba la cantidad de encuestas prevista en una manzana, se realizaba el reemplazo por otra manzana (Ministerio de Salud y Protección Social 2022).

El trabajo de campo se desarrolló entre el 2 de agosto y el 31 de octubre de 2022. Se realizaron 18.360 encuestas: 7.325 correspondientes al régimen contributivo, 9.574 al régimen subsidiado y 1.461 al régimen subsidiado/indígena. Los resultados fueron expandidos a 42.897.182 personas, sobre un universo de 48.899.985 afiliados a las EPS con corte a septiembre de 2022, equivalente a una cobertura del estudio del 87,72 % (Ministerio de Salud y Protección Social 2022).

El instrumento abordó aspectos relacionados con las características de los afiliados, satisfacción global, acceso, recomendación, estado de salud y trámites. Esta estructura muestra la continuidad de algunos temas de las mediciones anteriores, junto con una reorganización del contenido del cuestionario.

1.5.5 2023 --- Encuesta con énfasis en Atención Primaria en Salud

La medición de 2023 (Ministerio de Salud y Protección Social 2023) incorporó un énfasis explícito en la **Atención Primaria en Salud**, aspecto que se refleja tanto en el título como en el contenido del informe. El diseño fue **probabilístico, estratificado, de conglomerados y trietápico**, con selección de municipios, sectores censales y personas, mediante entrevista personal en los hogares.

El instrumento tuvo aproximadamente 75 preguntas y la presentación de los resultados incorporó seis macrorregiones: **Pacífico, Caribe, Central,**

Oriental, Bogotá y Orinoquía-Amazonía (Ministerio de Salud y Protección Social 2023). Esta desagregación amplió la forma de presentar los resultados frente a las ediciones anteriores.

Los principales elementos de diseño y muestra de esta edición se presentan en la tabla comparativa de la Sección 1.5.1; los aprendizajes metodológicos que deja el conjunto del ciclo se sintetizan en la Sección 1.6.

1.5.6 2024-2025 --- Mediciones inmediatamente anteriores a ENUS 2026

Las mediciones de 2024 y 2025 corresponden a las etapas más recientes de la serie de encuestas de satisfacción desarrolladas por la Oficina de Calidad del MSPS (Ministerio de Salud y Protección Social 2024, 2025).

En 2024, el informe se presentó bajo el título **“Informe de Resultados: Encuesta para Evaluar la Satisfacción de los Usuarios del Sistema de Salud Colombiano 2024”** (Ministerio de Salud y Protección Social 2024). A diferencia de la edición 2023, el título no incorpora una mención específica a la Atención Primaria en Salud, por lo que este énfasis debe entenderse como una característica particular de la medición de 2023.

Para 2025, el informe documenta un levantamiento realizado entre el 15 de septiembre y el 21 de diciembre, con **18.639 usuarios encuestados** en seis regiones del sistema de salud (Ministerio de Salud y Protección Social 2025). Los resultados muestran que el 53 % de las respuestas calificó la satisfacción como “buena” y el 10 % como “muy buena”; el 28 % respondió “ni buena ni mala” y el 8 % correspondió a las categorías negativas. En 18 de las 26 EPS evaluadas se registró una disminución de la satisfacción frente al año anterior (Ministerio de Salud y Protección Social 2025).

Estas mediciones constituyen los antecedentes más recientes de ENUS 2026 y muestran la continuidad de la medición de satisfacción de los usuarios hasta el periodo inmediatamente anterior a la nueva encuesta.

1.6 Aprendizajes de las mediciones históricas

Las mediciones realizadas entre 2005 y 2025 constituyen un antecedente importante para la ENUS 2026 y muestran una trayectoria institucional sostenida del Ministerio de Salud y Protección Social en el seguimiento de la percepción y satisfacción de los usuarios frente a los servicios de salud. Durante este periodo se desarrollaron diferentes ejercicios de medición que permitieron conocer la valoración de los usuarios e incorporar progresivamente nuevos temas relacionados con su interacción con el sistema de salud.

Sin embargo, estas mediciones no fueron realizadas bajo condiciones constantes. A lo largo del periodo cambiaron la población incluida, el periodo de referencia, la forma de seleccionar a los participantes, los instrumentos, los temas evaluados y las modalidades de recolección. En consecuencia, los resultados publicados para los diferentes años no constituyen una única serie estadística homogénea.

Esta diferencia es fundamental para interpretar los resultados históricos. Una variación observada entre dos años puede reflejar un cambio real en la percepción de los usuarios, pero también puede estar relacionada con modificaciones en las personas incluidas en la encuesta, la forma en que fueron seleccionadas, las preguntas utilizadas o las condiciones en las que se realizó la recolección.

1.6.1 Cambios en la población incluida

La población considerada en las mediciones no permaneció constante. Hasta 2014, las mediciones documentadas se concentraban en personas mayores de 18 años, mientras que desde 2015 se incorporaron también los menores de edad. También cambiaron las condiciones de inclusión y exclusión de los usuarios y, en algunas ediciones, el periodo utilizado para determinar si una persona había utilizado los servicios de salud.

El cambio ocurrido entre 2014 y 2015 es especialmente ilustrativo. La inclusión de menores de edad amplió el grupo de personas al que se referían los resultados. El universo de estudio pasó de 11.425.380 usuarios en 2014 a 16.555.627 en 2015. Por esta razón, una diferencia en los resultados entre estos dos años no puede interpretarse directamente como un cambio en la satisfacción de los usuarios, ya que también cambió la población a la que se referían esos resultados.

Algo similar ocurrió con las exclusiones. A lo largo de la serie se incorporaron diferentes grupos que no fueron considerados en las mediciones, entre ellos afiliados a regímenes especiales, personas con medicina prepagada, planes complementarios o seguros privados. Como resultado, el grupo de personas representado por los resultados fue cambiando con el tiempo.

1.6.2 Cambios en la forma de seleccionar a los usuarios

También cambió la forma en que se seleccionaron las personas que participaron en las encuestas. En 2017, por ejemplo, la muestra se construyó mediante la selección de municipios, manzanas y personas, mientras que en 2020, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, se pasó de un diseño basado en áreas a uno basado en listas de afiliados y se sustituyó la entrevista presencial por entrevistas telefónicas.

En 2022 se retomó la recolección presencial, mediante selección de barrios y manzanas y un barrido de hogares. En 2023 nuevamente se implementó un diseño probabilístico trietápico.

Estos cambios pueden modificar la composición de las personas que finalmente participan en la encuesta y la forma en que los resultados representan a la población. Por ello, aun cuando dos mediciones utilicen preguntas similares, sus resultados no necesariamente son directamente comparables.

1.6.3 Cambios en los temas y preguntas

La comparabilidad también se ve afectada por los cambios en el contenido de las mediciones.

Las primeras experiencias estuvieron orientadas a la percepción de calidad y, posteriormente, las mediciones del MSPS se concentraron principalmente en la satisfacción de los usuarios. Dentro de este ciclo también cambiaron los temas incluidos y la forma de organizar los resultados. El ranking de 2018, por ejemplo, reorganizó los indicadores de la medición de 2017 y sustituyó la dimensión de acceso por trámites. En 2023 se incorporó un énfasis explícito en atención primaria en salud.

Esto significa que los resultados de diferentes años no siempre representan exactamente el mismo aspecto de la relación entre los usuarios y el sistema de salud. Por tanto, observar que un porcentaje aumentó o disminuyó entre dos años no es suficiente para concluir que existe una tendencia histórica de mejora o deterioro.

1.6.4 El cambio de modalidad de recolección en 2020

La medición de 2020 constituye un punto particularmente importante de esta trayectoria. La pandemia obligó a sustituir la entrevista presencial por la entrevista telefónica y llevó a modificar el diseño muestral. La cobertura inicialmente prevista de 157 municipios tuvo que ampliarse a 541 municipios debido a las dificultades para alcanzar el número de entrevistas requerido.

Este cambio no fue únicamente operativo. La modificación de la forma de contactar a los usuarios y del marco utilizado para seleccionarlos cambió las condiciones bajo las cuales se obtuvieron los resultados. Por esta razón, los resultados de 2020 deben interpretarse dentro de las condiciones particulares de esa medición y no como una observación completamente equivalente a las mediciones presenciales anteriores o posteriores.

1.7 ENUS 2026 como nueva línea base de medición

En conjunto, las mediciones históricas muestran una trayectoria institucional importante y permiten identificar los temas que han sido relevantes para los usuarios, así como los principales aprendizajes relacionados con la población estudiada, el diseño de las encuestas, la recolección y la construcción de los indicadores. Al mismo tiempo, las diferencias acumuladas entre las distintas ediciones hacen que **la serie 2005-2025 no sea adecuada para establecer una única línea de tendencia de satisfacción o experiencia del usuario**: los resultados de cada operación conservan su valor como evidencia histórica, pero no deben interpretarse como observaciones sucesivas de una misma encuesta realizada bajo condiciones constantes.

A esta discontinuidad metodológica se suma una discontinuidad normativa. Las mediciones descritas en este capítulo corresponden a ejercicios sucesivos del Ministerio de Salud y Protección Social, cada uno con su propia ficha técnica, sin un marco normativo específico que los articulara como una única serie. ENUS 2026, en cambio, cuenta con un fundamento normativo propio: la Resolución 1642 de 2026, expedida el 31 de julio de 2026, adopta la **Encuesta Nacional de Experiencia del Usuario en Salud (ENUS)** como instrumento oficial y establece que su naturaleza es permanente y continua. La resolución define la ENUS como un instrumento digital para recoger información sobre la experiencia del afiliado frente a los servicios recibidos, y dispone que su diseño metodológico debe garantizar la representatividad estadística, el control sobre la generación de la información, la comparabilidad de los resultados en el tiempo y la reducción de los sesgos asociados a la autoselección de los participantes (Ministerio de Salud y Protección Social 2026).

La resolución establece además que la ENUS debe generar información sobre el desempeño de las EPS, las IPS y los gestores farmacéuticos, mediante indicadores organizados de acuerdo con los atributos de calidad definidos en la normativa vigente. El Ministerio deberá establecer mediante lineamientos técnicos los indicadores, sus fuentes, periodicidad y metodología de cálculo, así como los estándares técnicos necesarios para la operación del aplicativo y el intercambio de información (Ministerio de Salud y Protección Social 2026).

Por estas dos razones —metodológica y normativa—, la ENUS 2026 no debe entenderse como una nueva edición de las encuestas históricas de satisfacción, sino como el **punto de partida de una nueva serie de medición de la satisfacción y la experiencia del usuario en salud**. La primera medición establecerá la línea base sobre la cual se realizarán las mediciones posteriores.

Para que esta nueva serie sea comparable, la ENUS 2026 debe mantener

estables, desde su primera aplicación, una definición clara de la población objetivo, un diseño muestral documentado, procedimientos reproducibles de selección y ponderación, un instrumento estructurado a partir de una definición estable de experiencia del usuario, y reglas claras para el procesamiento, estimación y cálculo de indicadores. Cuando sea necesario introducir cambios en alguno de estos elementos, deberán documentarse y evaluarse antes de incorporarlos a la serie, de manera que sea posible identificar y tratar adecuadamente cualquier ruptura de comparabilidad.

De esta manera, las mediciones realizadas antes de 2026 cumplen una función fundamental como **antecedentes históricos** —metodológicos y de contenido—, y la Resolución 1642 de 2026 aporta el fundamento institucional que ninguna de ellas tuvo. A partir de esta línea base, los cambios observados en las mediciones posteriores de ENUS podrán interpretarse con mayor confianza como cambios en la experiencia de los usuarios y no como consecuencia de modificaciones en la propia operación estadística.

1.8 Referentes internacionales para la medición de la experiencia del usuario en salud

La medición de la experiencia de las personas usuarias se ha desarrollado en diferentes sistemas de salud como una forma de complementar la información proveniente de registros administrativos, indicadores clínicos y evaluaciones institucionales. Estos instrumentos parten de una idea común: algunos aspectos de la calidad de la atención solo pueden conocerse preguntando directamente a las personas que recibieron el servicio.

Para ENUS 2026 se consideran tres referentes internacionales particularmente relevantes: **CAHPS**, desarrollado en Estados Unidos; el marco de **responsiveness** de la Organización Mundial de la Salud; y **PaRIS**, promovido por la OCDE. Estos referentes no constituyen modelos que ENUS 2026 adopte o replique directamente. Su utilidad consiste en aportar antecedentes para definir el concepto de experiencia del usuario, identificar dimensiones relevantes y reconocer buenas prácticas para producir información comparable.

1.8.1 CAHPS: medición estandarizada de la experiencia del paciente

El programa **Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems (CAHPS)**, desarrollado por la Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) de Estados Unidos, constituye uno de los referentes más

consolidados para la medición estandarizada de la experiencia de los pacientes. El programa se inició en 1995 y ha desarrollado diferentes instrumentos para evaluar experiencias con planes de salud, profesionales, hospitales y otros servicios de atención (Agency for Healthcare Research and Quality 1995).

Un aspecto central de CAHPS es la distinción entre **experiencia del paciente y satisfacción**. Las encuestas buscan conocer lo que ocurrió durante la atención, por ejemplo, si los profesionales se comunicaron adecuadamente, si el usuario pudo acceder a la atención que necesitaba o si recibió la atención de manera oportuna. Esto se complementa con preguntas de valoración global sobre el proveedor o el servicio (Agency for Healthcare Research and Quality 1995).

Los instrumentos CAHPS utilizan preguntas estandarizadas y producen medidas individuales y medidas compuestas. Estas últimas agrupan varias preguntas relacionadas para representar dimensiones específicas de la experiencia. El programa señala que los elementos centrales de sus cuestionarios se mantienen estandarizados para favorecer la consistencia y comparabilidad de las mediciones (Agency for Healthcare Research and Quality 2024).

Para ENUS 2026, el principal aprendizaje de CAHPS es la necesidad de diferenciar entre **lo que el usuario experimentó durante la atención y la valoración general que hace del servicio**. Esta distinción es fundamental para la definición de las dimensiones e indicadores de experiencia desarrollada en el marco conceptual (3.1).

CAHPS también constituye un referente para la construcción de una serie de largo plazo: la estandarización de un núcleo de preguntas permite comparar resultados entre proveedores y a través del tiempo, sin impedir la incorporación de módulos o preguntas complementarias cuando sean necesarias (Agency for Healthcare Research and Quality 1995).

1.8.2 OMS: capacidad de respuesta de los sistemas de salud

La Organización Mundial de la Salud incorporó el concepto de **responsiveness** como uno de los componentes para evaluar el desempeño de los sistemas de salud en el *World Health Report 2000* (World Health Organization 2000). El concepto se refiere a la manera en que el sistema responde a las expectativas legítimas de las personas en aspectos que no corresponden directamente a los resultados clínicos de la atención.

El marco desarrollado por la OMS agrupa estas expectativas en dos grandes componentes: **respeto por las personas y orientación al usuario**. El primero incluye aspectos como dignidad, confidencialidad y autonomía; el

segundo incorpora elementos como atención oportuna, calidad de las condiciones básicas, posibilidad de elegir proveedor y acceso a redes de apoyo durante la atención (World Health Organization 2000).

Este referente resulta relevante porque amplía la mirada sobre la calidad de los servicios de salud. La experiencia del usuario no se limita a determinar si el tratamiento fue clínicamente adecuado, sino que también incluye la forma en que la persona fue tratada, escuchada, informada y atendida.

Para ENUS 2026, el principal aporte de este marco es la incorporación de dimensiones relacionadas con **trato digno, autonomía, confidencialidad, oportunidad, comunicación y condiciones de atención**, que pueden ser observadas directamente desde la perspectiva de las personas usuarias.

1.8.3 OCDE-PaRIS: experiencias y resultados reportados por los pacientes

El programa **Patient-Reported Indicator Surveys (PaRIS)** de la OCDE representa una etapa más reciente en el desarrollo de mediciones internacionales centradas en la perspectiva de los pacientes. Su objetivo es desarrollar indicadores estandarizados sobre los resultados y las experiencias de atención que son relevantes para las personas (OECD 2025).

El primer ciclo de PaRIS, desarrollado entre 2017 y 2025, reunió información de más de **107.000 pacientes**, atendidos en más de **1.800 centros de atención primaria de 19 países**. La población estudiada estuvo conformada por pacientes de atención primaria de 45 años o más, con especial atención a personas con enfermedades crónicas (OECD 2025).

Una característica importante de PaRIS es la integración de dos tipos de información: los **resultados reportados por los pacientes (PROM)** y las **experiencias reportadas por los pacientes (PREM)**. Esta distinción permite separar lo que ocurrió durante la atención de los resultados que la persona percibe en relación con su salud y bienestar.

Para ENUS 2026, PaRIS aporta principalmente dos elementos. El primero es la importancia de construir indicadores estandarizados que permitan comparar resultados entre territorios y a través del tiempo. El segundo es la conveniencia de distinguir entre **experiencia de atención y resultados de salud reportados por las personas**, evitando que ambos conceptos se mezclen en un mismo indicador.

1.8.4 Elementos comunes de los referentes internacionales

Aunque CAHPS, el marco de *responsiveness* de la OMS y PaRIS tienen objetivos, poblaciones y contextos diferentes, presentan algunos elementos comunes que resultan relevantes para ENUS 2026:

1. **La persona usuaria es una fuente directa de información sobre la calidad de la atención.** Determinados aspectos de la atención no pueden conocerse únicamente mediante registros clínicos o administrativos.
2. **La experiencia debe distinguirse de la satisfacción.** La experiencia se centra principalmente en hechos y situaciones ocurridas durante la atención, mientras que la satisfacción corresponde a una valoración global de esa experiencia.
3. **La experiencia es multidimensional.** Aspectos como comunicación, acceso, oportunidad, trato, participación y coordinación pueden medirse por separado y posteriormente integrarse en un sistema de indicadores.
4. **La estandarización es necesaria para la comparación.** Mantener definiciones, preguntas e indicadores centrales permite interpretar los cambios observados entre mediciones como cambios en la experiencia y no como efectos derivados de modificaciones en el instrumento.
5. **La información debe estar orientada a la mejora.** Estos instrumentos no se limitan a producir un resultado agregado; buscan identificar dimensiones en las que existen diferencias entre proveedores, territorios o grupos de población.

Estos elementos constituyen referentes para la construcción del marco conceptual de ENUS 2026, pero no determinan por sí mismos el diseño de la operación. La definición de las dimensiones, el instrumento, la población objetivo, el mecanismo de captación, el diseño muestral, la ponderación y los procedimientos de estimación se establecen de acuerdo con las características del sistema de salud colombiano y se desarrollan en los capítulos correspondientes de este documento.

Capítulo 2

Objetivo de la ENUS 2026

2.1 Objetivo general

Medir la *satisfacción y la experiencia de las personas usuarias* del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) con los servicios de salud utilizados, mediante una operación estadística de recolección continua, para producir información periódica, comparable y estadísticamente sustentada que contribuya al seguimiento, la evaluación y el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud.

2.2 Objetivos específicos

1. *Medir la satisfacción de las personas usuarias* con los servicios de salud utilizados, como valoración general de la atención recibida.
2. *Medir las principales dimensiones de la experiencia del usuario* en la interacción con los servicios de salud, considerando aspectos relacionados con la accesibilidad, oportunidad, trato digno, comunicación y resolutivez.
3. *Producir información periódica y oportuna* sobre la satisfacción y la experiencia de las personas usuarias mediante un esquema de recolección continua que permita identificar cambios en los principales indicadores con menor rezago temporal.
4. *Minimizar el potencial sesgo de recuerdo* mediante la recolección de información en proximidad temporal a la utilización del servicio de salud, favoreciendo un reporte más cercano a la experiencia efectivamente vivida por la persona usuaria.

5. *Producir estimaciones para los principales dominios de interés de la operación, incluyendo características sociodemográficas, de afiliación, territoriales y relacionadas con el tipo de servicio utilizado, siempre que los niveles de precisión y confiabilidad estadística permitan sustentar dichas desagregaciones.*
6. *Mantener la comparabilidad temporal de los principales indicadores de satisfacción y experiencia del usuario con las mediciones anteriores, preservando la continuidad conceptual y metodológica cuando resulte pertinente y documentando los cambios que puedan afectar la interpretación de las series.*
7. *Proporcionar información estadística pertinente para el seguimiento de la satisfacción y experiencia de los usuarios, que contribuya a la evaluación y al mejoramiento de las políticas, estrategias y acciones relacionadas con la calidad de los servicios de salud.*

Capítulo 3

Alcance de la operación estadística

El alcance de ENUS 2026 delimita los fenómenos objeto de medición, la población a la que se refieren los resultados, las unidades de observación, la cobertura territorial y temporal, los servicios de salud considerados y los principales dominios de análisis. Estas definiciones establecen el ámbito de interpretación de los resultados y los límites de la información que puede producir la operación estadística.

3.1 Fenómenos objeto de medición

ENUS 2026 mide dos fenómenos relacionados pero conceptualmente diferenciados: la *satisfacción de las personas usuarias con los servicios de salud utilizados* y la *experiencia de las personas usuarias durante su interacción con dichos servicios*.

La *satisfacción* corresponde a la valoración general que realiza la persona usuaria sobre el servicio recibido, expresando su grado de conformidad con la atención proporcionada; es una medida global y retrospectiva, en continuidad con la serie histórica de mediciones del SGSSS (1).

La *experiencia del usuario* comprende, en cambio, hechos concretos ocurridos durante la interacción con los servicios de salud —distintos de esa valoración global—. Los atributos observados en la aplicación de recolección de ENUS 2026 son el acceso (correspondiente a la accesibilidad exigida por el SOGCS), el tiempo de espera (correspondiente a la oportunidad exigida por el SOGCS, 1), la humanización del trato y la entrega de medicamentos.

Ambos fenómenos se miden de manera complementaria: la satisfacción proporciona una valoración global de la atención recibida, mientras que los atributos de experiencia permiten caracterizar los aspectos concretos de la interacción que contribuyen a dicha valoración. Este enfoque combinado — valoración global junto con hechos concretos— sigue el mismo patrón que utilizan los referentes internacionales identificados en los antecedentes de este documento, en particular CAHPS (1).

ENUS 2026 mide percepciones y valoraciones reportadas directamente por las personas usuarias. Por tanto, sus resultados no constituyen mediciones directas de resultados clínicos, desenlaces en salud, efectividad de los tratamientos ni de la calidad técnica de la atención, salvo en aquellos aspectos que sean explícitamente operacionalizados mediante el instrumento.

3.2 Población objetivo

La población objetivo de ENUS 2026 está constituida por las *personas afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) que hayan utilizado, durante alguno de los trimestres del año de referencia, al menos uno de los servicios de salud incluidos en el ámbito de medición de la encuesta*.

La población comprende las personas afiliadas a los regímenes considerados por el SGSSS, independientemente de su sexo, edad, territorio de residencia u otras características sociodemográficas. La utilización de un servicio de salud durante el año de referencia constituye la condición que vincula a la persona con el fenómeno objeto de medición, dado que las preguntas de satisfacción y experiencia se refieren a una atención o servicio efectivamente utilizado.

Para efectos de la operación estadística, la identificación de las personas elegibles se realiza de manera continua durante el año, tomando como periodo de referencia para la utilización del servicio cada trimestre calendario. En consecuencia, para cada trimestre se consideran las personas que cumplen simultáneamente las siguientes condiciones:

1. *Afiliación al SGSSS*: encontrarse afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud durante el periodo correspondiente a la utilización del servicio.
2. *Utilización de servicios de salud*: haber utilizado al menos uno de los servicios de salud incluidos en el ámbito de ENUS 2026.
3. *Periodo de referencia*: que la utilización del servicio haya ocurrido durante el trimestre correspondiente.

Los cuatro trimestres conforman el periodo anual de referencia de la operación. De esta manera, la recolección se desarrolla de forma continua a lo largo del año, mientras que la producción principal de resultados corresponde al *año de referencia*, integrando la información recolectada durante sus respectivos periodos trimestrales.

La identificación y selección de las personas pertenecientes a la población objetivo se realizará mediante los mecanismos de captación y verificación definidos para la operación estadística. Estos mecanismos podrán apoyarse en diferentes fuentes de información y herramientas tecnológicas y podrán modificarse durante el ciclo de vida de la encuesta sin alterar la definición conceptual de la población objetivo.

La población efectivamente observada estará constituida por las personas de la población objetivo que sean captadas o seleccionadas mediante los procedimientos establecidos y que proporcionen información válida para la estimación de los indicadores.

La definición de la población objetivo, los criterios de elegibilidad y los procedimientos de selección deberán garantizar que la información recolectada durante los cuatro trimestres permita producir estimaciones anuales representativas de la población objetivo del año correspondiente.

3.3 Unidad de observación

La unidad de observación de ENUS 2026 es la persona afiliada al SGSSS que haya utilizado un servicio de salud incluido en el ámbito de la operación durante el periodo de referencia.

La información recolectada corresponde a la satisfacción y experiencia reportadas por la persona respecto del servicio utilizado. Las EPS, IPS, gestores farmacéuticos y demás actores relacionados con la prestación de los servicios no constituyen unidades de observación.

3.4 Cobertura territorial

ENUS 2026 tendrá cobertura nacional, con una distribución de la muestra que garantizará una cuota mínima de participación para cada región definida en la operación.

La región constituye el nivel territorial mínimo previsto para la producción de resultados. La participación efectiva de los usuarios podrá permitir desagregaciones territoriales adicionales dentro de cada región, siempre que se alcance un número suficiente de observaciones y condiciones adecuadas de calidad estadística para su interpretación.

3.5 Cobertura temporal y periodo de referencia

ENUS 2026 adopta un esquema de *recolección continua durante el año*, organizado en cuatro periodos trimestrales de referencia.

El periodo de referencia corresponde al *trimestre en el que la persona utilizó el servicio de salud* objeto de la medición. La satisfacción y experiencia reportadas se refieren a dicha utilización.

La recolección continua permite aproximar el momento de la encuesta al momento de utilización del servicio, reduciendo el potencial efecto del recuerdo retrospectivo.

Los resultados de ENUS 2026 se producirán con *periodicidad anual*, integrando la información recolectada durante los cuatro trimestres del año de referencia.

3.6 Servicios de salud objeto de medición

ENUS 2026 mide la satisfacción y experiencia de las personas usuarias frente a los *servicios de salud incluidos en el ámbito de la operación*.

La medición se realiza de acuerdo con el tipo de servicio utilizado, de manera que el instrumento permita recoger las características específicas de la interacción de la persona con el sistema de salud.

La clasificación de los servicios considerados y la asignación de las preguntas correspondientes hacen parte de la estructura del instrumento de recolección.

3.7 Dominios de análisis

ENUS 2026 contempla la producción de resultados para el *total nacional y para las regiones definidas en la operación*, de acuerdo con las cuotas mínimas de participación establecidas para cada una.

La información recolectada permitirá explorar desagregaciones adicionales según características de las personas usuarias, de su afiliación y del servicio utilizado. La disponibilidad de estas desagregaciones dependerá de la participación efectiva alcanzada en las categorías correspondientes y de las condiciones de calidad requeridas para su presentación e interpretación.

Los principales resultados corresponderán a indicadores de *satisfacción y experiencia del usuario*, tanto de manera general como para las dimen-

siones consideradas en el instrumento, de acuerdo con el tipo de servicio evaluado.

3.8 Límites del alcance

El alcance de ENUS 2026 está determinado por la población objetivo, los servicios de salud incluidos, el instrumento de recolección y el diseño de la operación estadística.

Los resultados corresponden a la *satisfacción y experiencia reportadas por las personas participantes* respecto de los servicios de salud utilizados. No constituyen una medición integral del desempeño del SGSSS ni sustituyen otras fuentes de información requeridas para evaluar resultados clínicos, desenlaces en salud, efectividad de tratamientos o calidad técnica de la atención.

La cobertura mínima por región se establece mediante cuotas de participación. Las desagregaciones adicionales estarán condicionadas por la participación efectiva alcanzada y por criterios de suficiencia y calidad de la información.

La Resolución 1642 de 2026 habilita la desagregación de los resultados de ENUS por EPS, institución prestadora, departamento, distrito y municipio, entre otros niveles (Ministerio de Salud y Protección Social 2026). Esta habilitación normativa no debe confundirse con una garantía de precisión estadística en esos niveles: el diseño muestral de la operación solo asegura la precisión nominal a nivel de región; las desagregaciones por EPS, institución prestadora o municipio dependerán de la participación efectivamente alcanzada en cada categoría y podrán no ser publicables si no cumplen los criterios de suficiencia y calidad establecidos.

Dado el carácter no probabilístico de la operación, las desagregaciones y resultados deberán interpretarse de acuerdo con el alcance del diseño de selección y con las condiciones bajo las cuales se obtuvo la información.

Capítulo 4

Diseño muestral

El diseño muestral de la ENUS 2026 establece los criterios estadísticos y operativos utilizados para determinar la composición esperada de la muestra y distribuir la participación entre los diferentes grupos de interés. En particular, define el tamaño objetivo de la operación, su distribución territorial y demográfica, y las reglas utilizadas para conformar las cuotas de participación.

La ENUS 2026 emplea un esquema de **muestreo no probabilístico por cuotas**. Por tanto, la inclusión de las personas participantes no se realiza mediante un mecanismo de selección aleatoria con probabilidades de inclusión conocidas. En su lugar, la operación establece metas de participación para un conjunto de celdas definidas a partir de características demográficas y de afiliación, y la captación se desarrolla hasta alcanzar dichas metas.

La definición de las cuotas parte de la población objetivo establecida en el capítulo anterior ((?)(sec-poblacion-objetivo)) y utiliza información poblacional de la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) como referencia para determinar la distribución esperada de la muestra. Esta información permite orientar la composición de la muestra hacia la estructura observada de la población de referencia, sin que ello convierta a la BDUA en un marco de selección probabilística.

El diseño se estructura en dos niveles. Primero, se determina un tamaño objetivo para cada región, de manera que la operación disponga de un número suficiente de observaciones para producir resultados con el nivel de desagregación territorial previsto. Segundo, el tamaño asignado a cada región se distribuye entre las celdas definidas por régimen de afiliación, sexo, grupo de edad y zona, utilizando la estructura poblacional de referencia y estableciendo mínimos de participación para las celdas de menor tamaño.

En consecuencia, las cuotas constituyen **metas de composición de la muestra y no probabilidades de selección**. Su función es orientar la captación y reducir desequilibrios conocidos entre la muestra y la población de referencia. Los ajustes posteriores mediante ponderación y calibración cumplen una función complementaria y se desarrollan en el capítulo correspondiente.

A partir de esta estructura, el presente capítulo desarrolla la determinación del tamaño objetivo, la asignación de las cuotas, la definición de las celdas de participación y la diferenciación entre los conceptos de cuota, estrato, dominio y variable de calibración. Finalmente, se precisan las implicaciones del diseño para el alcance inferencial de los resultados.

4.1 Esquema de cuotas y composición de la muestra

La participación en la ENUS 2026 se estructura mediante un sistema de *cuotas previamente definidas*, que establece metas de participación para las regiones y demás características consideradas en el diseño. Estas cuotas permiten orientar la composición de la muestra durante la captación y controlar el cumplimiento de las metas establecidas para cada grupo.

Las cuotas constituyen metas de composición y no probabilidades de selección. En consecuencia, su cumplimiento no implica que las personas tengan una probabilidad conocida de inclusión en la muestra ni que la estructura final resulte de un mecanismo de selección aleatoria.

Esta característica tiene implicaciones para los procedimientos posteriores de ponderación, calibración y estimación, así como para la interpretación del alcance inferencial de los resultados. Los procedimientos estadísticos empleados para el tratamiento de estas consideraciones se desarrollan en las secciones correspondientes.

Los mecanismos, canales y herramientas utilizados para la captación de participantes constituyen componentes operativos de la recolección. Estos podrán modificarse durante el desarrollo de la operación para favorecer el cumplimiento de las metas de participación, sin que ello implique modificar la estructura estadística de las cuotas establecidas.

De manera general, la operación comprende la siguiente secuencia:

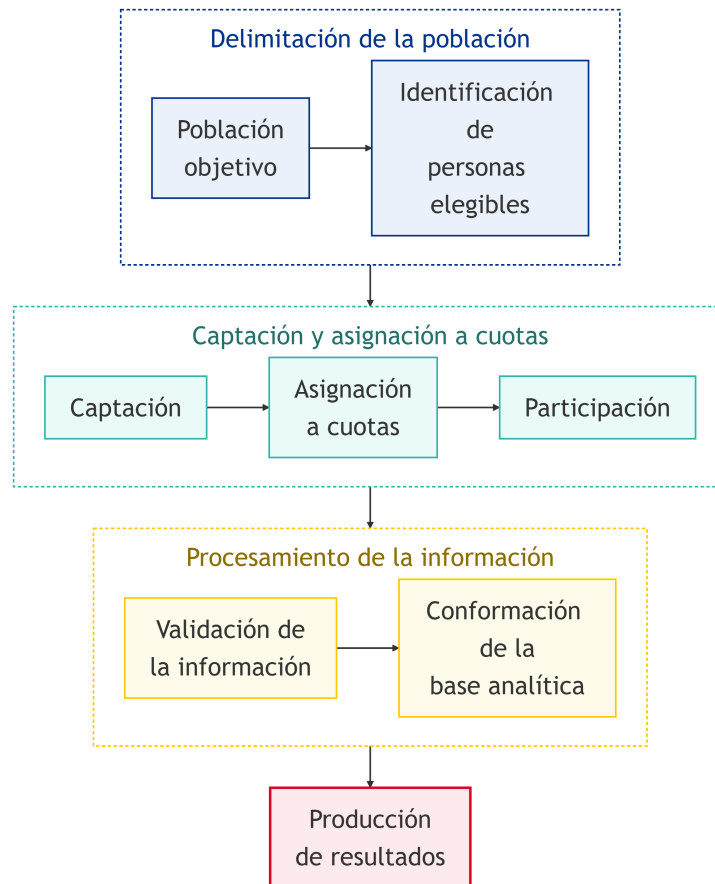


Figura 4.1: Secuencia operativa de la ENUS 2026, desde la población objetivo hasta la producción de resultados.

Los procedimientos específicos asociados con la determinación y distribución de las cuotas, la captación, el procesamiento de la información y la estimación se desarrollan en las secciones correspondientes del documento.

4.2 Determinación del tamaño de muestra

El tamaño objetivo de la operación se determina a partir de una precisión nominal definida para los principales indicadores. Para este propósito se utiliza como población de referencia la población afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), registrada en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), con corte a marzo de 2026, correspondiente a

$N = 50\,168\,746$ personas.

La BDUA se utiliza como fuente de referencia para establecer los parámetros poblacionales y posteriormente distribuir las metas de participación. Su utilización en este procedimiento no implica que la operación corresponda a un muestreo probabilístico ni que las personas incluidas tengan probabilidades de selección conocidas.

El cálculo parte de un escenario de muestreo aleatorio simple, utilizado como *referencia para establecer una meta nominal de participación*. Sobre este resultado se incorpora un efecto de diseño y, cuando corresponde, una corrección por población finita. Finalmente, se aplica un factor operativo para determinar la meta de captación necesaria frente a pérdidas esperadas durante la operación.

4.2.1 Cálculo de referencia

Para la estimación de una proporción, el tamaño de muestra bajo muestreo aleatorio simple se expresa como:

$$n_{MAS} = \frac{Z_{1-\alpha/2}^2 P(1-P)}{ME^2},$$

donde P es la proporción de referencia, $Z_{1-\alpha/2}$ corresponde al cuantil de la distribución normal asociado al nivel de confianza y ME es el margen de error absoluto. Esta formulación corresponde al cálculo convencional del tamaño de muestra para proporciones bajo muestreo aleatorio simple (Cochran 1977; Lohr 2021).

En la ENUS 2026 se adopta $P = 0,50$, valor que maximiza la varianza de una proporción y, por tanto, produce un tamaño de referencia conservador cuando no se dispone de una proporción previa.

El margen de error absoluto se obtiene a partir de la longitud total del intervalo de confianza definida para el diseño:

$$ME = Z_{1-\alpha/2} \left(\frac{L}{2} \right),$$

donde L representa la longitud total del intervalo.

Dado que el diseño utiliza un margen de error relativo, este se obtiene mediante:

$$MER = \frac{ME}{P}.$$

Con un nivel de confianza del 95 %, $P = 0,50$ y una longitud total del intervalo de 0,04, se obtiene:

$$ME = 1,96 \times 0,02 = 0,0392$$

y, por tanto,

$$MER = \frac{0,0392}{0,50} = 0,0784,$$

equivalente a un margen de error relativo del **7,84 %**.

El tamaño de referencia resultante es aproximadamente:

$$n_{MAS} \approx 625.$$

4.2.2 Ajuste por efecto de diseño

El tamaño de referencia se ajusta mediante un efecto de diseño ($DEFF$) de 1,5:

$$n_{DEFF} = n_{MAS} \times DEFF.$$

El efecto de diseño expresa la relación entre la varianza de un estimador bajo un determinado esquema de diseño y la varianza que tendría bajo muestreo aleatorio simple con igual tamaño de muestra. Su utilización permite incorporar, de manera aproximada, pérdidas de eficiencia asociadas con la estructura del diseño.

Para la ENUS 2026:

$$n_{DEFF} = 625 \times 1,5 \approx 938.$$

Este ajuste debe interpretarse como parte del procedimiento utilizado para establecer el tamaño objetivo y no como una estimación empírica de la varianza del diseño de la ENUS.

4.2.3 Corrección por población finita

Cuando el tamaño de la población del dominio no es suficientemente grande respecto del tamaño de muestra requerido, se incorpora la corrección por población finita:

$$n_{ajustado} = \frac{n_{DEFF}}{1 + \frac{n_{DEFF}}{N}}.$$

La corrección por población finita reduce el tamaño requerido cuando la fracción de muestreo deja de ser despreciable. Para poblaciones grandes respecto del tamaño de muestra, su efecto es prácticamente nulo (Cochran 1977).

En la ENUS 2026, los dominios considerados presentan tamaños poblacionales suficientemente grandes para que esta corrección tenga un efecto reducido. Para el dominio de menor tamaño, correspondiente a Orinoquía-Amazonía del régimen contributivo, con $N \approx 331\,029$, el tamaño se reduce de aproximadamente 938 a 935.

4.2.4 Ajuste operativo y meta de captación

Finalmente, el tamaño ajustado se incrementa mediante un factor operativo $f = 1, 4$, destinado a compensar anticipadamente pérdidas asociadas con no respuesta, imposibilidad de contacto y registros que no superen los criterios de validación establecidos para la operación:

$$n_{meta} = n_{ajustado} \times f.$$

Para los dominios considerados, este procedimiento conduce a una meta de captación del orden de **1 309 a 1 313 participaciones por dominio**.

Este resultado debe leerse como el *tamaño objetivo (meta) de cada cuota*, y no como el resultado de un cálculo de precisión bajo selección aleatoria: la fórmula se utiliza para fijar una meta de captación con una precisión nominal deseada, no para certificar que esa precisión se alcanza mediante un mecanismo probabilístico.

4.2.5 Parámetros adoptados

El procedimiento descrito proporciona una **referencia cuantitativa para establecer las metas de participación**. Dado que la ENUS 2026 utiliza un diseño no probabilístico por cuotas, los valores obtenidos no deben interpretarse como tamaños que garanticen, bajo el diseño implementado, un margen de error probabilístico determinado. En las muestras no probabilísticas no se dispone de probabilidades de inclusión conocidas que permitan derivar directamente el error de muestreo mediante la teoría clásica del muestreo probabilístico (Baker et al. 2013).

Cuadro 4.1: Parámetros adoptados para la determinación del tamaño de muestra objetivo, ENUS 2026.

Parámetro	Símbolo	Valor
Proporción de referencia	P	0,50
Nivel de confianza	$1 - \alpha$	95 %
Longitud total del intervalo	L	0,04
Margen de error absoluto	ME	0,0392
Margen de error relativo	MER	7,84 %
Efecto de diseño	$DEFF$	1,5
Factor operativo	f	1,4

La evaluación de la composición alcanzada, así como los procedimientos de ponderación y calibración utilizados posteriormente, se desarrollan en las secciones correspondientes.

4.2.6 Tamaño adoptado: asignación por región

El tamaño objetivo se establece en función del nivel de desagregación territorial previsto para la producción de resultados. Dado que la ENUS 2026 contempla a las seis regiones como dominios de análisis, la meta de participación se determina de manera independiente para cada una de ellas. De esta forma, la precisión nominal utilizada como referencia para definir el tamaño no se concentra únicamente en el agregado nacional, sino que se establece para cada región.

Las seis regiones siguen el esquema estándar de regionalización DA-NE/ENDS y agrupan los 32 departamentos del país junto con Bogotá D.C.:

Cuadro 4.2: Composición departamental de las seis regiones utilizadas como dominios de análisis, ENUS 2026.

Región	Departamentos que la conforman
Bogotá	Bogotá D.C.
Central	Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Caquetá
Oriental	Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Meta
Caribe	Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre, San Andrés
Pacífica	Cauca, Chocó, Nariño, Valle
Orinoquía-Amazonía	Arauca, Casanare, Vichada, Amazonas, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés

El cálculo realizado para el total nacional constituye únicamente una referencia para una estimación agregada del país. Si se utilizara exclusivamente ese valor, la muestra sería suficiente para establecer una meta de participación nacional, pero no para reproducir ese mismo criterio de tamaño en cada uno de los seis dominios regionales.

Por esta razón, el tamaño objetivo nacional se obtiene mediante la suma de las metas regionales:

$$n_{\text{nacional}} = \sum_{r=1}^6 n_r.$$

Con los tamaños adoptados para las seis regiones, se obtiene una meta nacional de **7.876 participaciones**. La diferencia entre los tamaños regionales responde al proceso de redondeo y ajuste requerido para que las metas regionales sean compatibles con la distribución posterior de las cuotas.

El régimen de afiliación no se utiliza como un nivel adicional e independiente para determinar el tamaño total. En consecuencia, no se asigna una meta de 1.313 participaciones a cada combinación región × régimen. Hacerlo implicaría establecer 12 metas independientes y elevaría sustancialmente el tamaño total de la operación.

En su lugar, el tamaño correspondiente a cada región constituye un presupuesto fijo de participación que posteriormente se distribuye entre los dos regímenes de afiliación de acuerdo con su participación poblacional en la BDUA. El régimen, por tanto, interviene en la **composición de la cuota regional**, pero no genera un tamaño adicional que deba sumarse al tamaño regional.

Esta decisión permite mantener el objetivo de participación establecido para cada región y, simultáneamente, reproducir dentro de cada una de ellas la estructura poblacional de los regímenes de afiliación. Las metas obtenidas para las combinaciones región × régimen constituyen, por tanto, componentes del tamaño regional y no dominios independientes de tamaño.

4.2.7 Asignación del tamaño de muestra por cuotas

Una vez definidos los tamaños objetivo regionales, cada región se desagrega en las celdas que conforman la estructura de cuotas. Las celdas resultan del cruce de cuatro variables:

- régimen de afiliación: contributivo y subsidiado;
- sexo: femenino y masculino;

- grupo de edad: 00–09, 10–19, 20–29, 30–39, 40–49, 50–59 y 60 años o más;
- zona: urbana y rural.

Esta estructura genera **56 celdas por región y 336 celdas para el conjunto nacional**.

La asignación inicial de cada celda se realiza de manera proporcional a su peso poblacional dentro de la región, utilizando como referencia la distribución observada en la BDUa con corte a marzo de 2026:

$$n_c = n_r \frac{N_c}{N_r},$$

donde n_c corresponde al tamaño inicial de la celda c , n_r al tamaño objetivo de la región a la que pertenece, N_c al número de personas de la celda en la BDUa y N_r al total de personas de la región.

Sobre esta asignación proporcional se establece un **mínimo de 10 participaciones por celda**, con el propósito de evitar que las categorías de menor tamaño poblacional queden excluidas de la estructura de cuotas:

$$n_c^* = \max \left\{ n_r \frac{N_c}{N_r}, 10 \right\}.$$

La aplicación del mínimo puede generar una suma superior o inferior al tamaño regional inicialmente distribuido. Por esta razón, la asignación definitiva incorpora un procedimiento de ajuste que conserva el tamaño total establecido para cada región y mantiene, en la medida permitida por las restricciones de mínimo, la relación proporcional derivada de la estructura poblacional.

Una vez obtenidas las asignaciones enteras, el ajuste final se realiza mediante el **método del resto mayor**. Para ello, se asigna inicialmente la parte entera de cada cuota y las unidades restantes se distribuyen entre las celdas con las mayores partes fraccionarias, hasta completar exactamente el tamaño regional establecido.

El procedimiento produce una estructura nacional de 336 cuotas. De ellas, 17 corresponden al mínimo de 10 participaciones, mientras que la cuota de mayor tamaño alcanza 72 participaciones. El establecimiento de un mínimo implica una sobrerrepresentación deliberada de las celdas demográficamente menos numerosas respecto de su peso poblacional. Esta decisión responde a la necesidad operativa de conservar participación en los grupos de menor tamaño y será considerada posteriormente en la construcción y calibración de los pesos analíticos.

4.2.8 Resultado agregado por región y régimen

La agregación de las 56 celdas correspondientes a cada región permite obtener la distribución de la meta regional entre los dos regímenes de afiliación:

Cuadro 4.3: Distribución de la meta de cuota por región y régimen de afiliación, ENUS 2026.

Región	Contributivo	Subsidiado	Total región
Bogotá	855	458	1.313
Caribe	494	819	1.313
Central	663	650	1.313
Oriental	629	684	1.313
Orinoquía-Amazonía	453	858	1.311
Pacífica	575	738	1.313
Total nacional	3.669	4.207	7.876

La distribución muestra que la composición por régimen varía entre regiones de acuerdo con la estructura poblacional de referencia. No obstante, las metas de ambos regímenes se encuentran contenidas dentro del tamaño total definido para cada región.

4.2.9 Composición agregada de las cuotas

La agregación de las cuotas a nivel nacional produce la siguiente composición según sexo:

Cuadro 4.4: Composición agregada de la cuota nacional por sexo, ENUS 2026.

Sexo	<i>n</i>	%
Femenino	3.993	50,7 %
Masculino	3.883	49,3 %

Por grupo de edad:

Cuadro 4.5: Composición agregada de la cuota nacional por grupo de edad, ENUS 2026.

Grupo de edad	<i>n</i>	%
00–09	1.014	12,9 %
10–19	1.163	14,8 %
20–29	1.203	15,3 %
30–39	1.203	15,3 %
40–49	1.086	13,8 %
50–59	975	12,4 %
60 o más	1.232	15,6 %

Y por zona:

Cuadro 4.6: Composición agregada de la cuota nacional por zona, ENUS 2026.

Zona	<i>n</i>	%
Urbana	5.147	65,4 %
Rural	2.729	34,6 %

La matriz completa de cuotas, correspondiente a las 336 combinaciones de región, régimen, sexo, grupo de edad y zona, se presenta como anexo externo al documento en el **Anexo E — Matriz de cuotas**, organizado en una hoja independiente para cada región.

4.2.10 Papel de las EPS, IPS y gestores en la captación

La participación de las EPS, IPS y gestores farmacéuticos constituye un componente relevante de la estrategia de captación de la ENUS 2026. Aunque estas entidades no reciben una cuota de participación asignada de manera independiente, su participación en la operación puede facilitar el acceso de los usuarios al cuestionario y contribuir al cumplimiento de las metas definidas para las cuotas demográficas.

La necesidad de este apoyo responde a una condición operativa relevante: **no todas las personas de la población objetivo disponen de teléfono inteligente, conexión a Internet, computador u otros medios digitales que les permitan diligenciar directamente el cuestionario**. Por esta razón, la operación debe contemplar mecanismos que permitan que los usuarios puedan acceder al instrumento y completar su diligenciamiento con el apoyo de las instituciones que participan en la atención en salud.

En este contexto, las EPS, IPS y gestores pueden desempeñar un papel de facilitación, orientando a los usuarios elegibles hacia el mecanismo de participación y, cuando sea necesario, proporcionando apoyo para el diligenciamiento del cuestionario. Este apoyo no implica que las entidades constituyan unidades de selección ni que se establezcan cuotas institucionales; su función corresponde al componente operativo de acceso y captación.

La participación institucional debe desarrollarse de manera que el usuario conserve la autonomía para decidir si participa en la encuesta y que las respuestas sean registradas directamente por el usuario o con su consentimiento y acompañamiento, según el mecanismo operativo definido para la recolección.

En consecuencia, la cantidad de participantes provenientes de cada EPS, IPS o gestor no constituye una meta de cuota predeterminada. Su distribución dependerá de la participación efectiva de los usuarios y de los mecanismos de acceso y apoyo disponibles durante la operación. La estructura institucional observada en la muestra será, por tanto, un resultado de la captación y no una dimensión controlada mediante cuotas.

4.2.11 Diferenciación conceptual para el análisis

Para la interpretación de los resultados es necesario distinguir entre los conceptos utilizados para organizar la captación y aquellos utilizados posteriormente para producir y analizar los resultados. Aunque una misma variable puede intervenir en más de una de estas funciones, su propósito estadístico es diferente.

- **Cuota.** Corresponde a una meta de composición establecida previamente para orientar la captación. En la ENUS 2026, las cuotas se definen mediante el cruce de región, régimen, sexo, grupo de edad y zona. Su función es controlar la composición de la muestra durante la operación.

Por ejemplo, una cuota podría corresponder a Caribe – régimen subsidiado – femenino – 30 a 39 años – urbano, con una meta determinada de participaciones. Si durante la captación ya se alcanzó la meta de esta celda, nuevas personas con esas mismas características no incrementan esa cuota y la operación debe orientar la captación hacia otras celdas que aún tengan participación disponible.

La cuota, por tanto, responde a la pregunta: *¿cuántas personas se espera captar con determinadas características?*

- **Estrato.** En el muestreo probabilístico, un estrato corresponde a una partición de la población dentro de la cual se realiza la selección de unidades mediante un mecanismo de muestreo definido. Las celdas

utilizadas para las cuotas de la ENUS 2026 no deben interpretarse automáticamente como estratos probabilísticos, dado que la captación dentro de ellas no se realiza mediante selección aleatoria con probabilidades de inclusión conocidas (Cochran 1977; Kish 1965).

Por ejemplo, la celda Caribe – subsidiado – femenino – 30 a 39 años – urbano puede ser una cuota de captación, pero no constituye por sí misma un estrato probabilístico. Para que existiera un estrato en el sentido clásico, debería existir una población definida dentro de ese grupo y un mecanismo de selección probabilística de las unidades que lo conforman.

El estrato, por tanto, responde a una pregunta diferente: *¿dentro de qué partición de la población se realiza la selección probabilística?*

- **Dominio de análisis.** Es un grupo de personas para el cual se desea producir un resultado específico. A diferencia de la cuota, el dominio se define por la necesidad de análisis y no necesariamente corresponde a una categoría con una meta de captación.

Por ejemplo, la cuota puede definirse para Caribe × Subsidiado × Femenino × 30–39 × Urbano, mientras que posteriormente puede analizarse el resultado para todo el régimen subsidiado, agrupando personas de todas las regiones, edades, sexos y zonas. En este caso, “régimen subsidiado” es un dominio, pero no una cuota independiente.

También pueden analizarse dominios que no hacen parte de la estructura de cuotas, como *EPS, IPS o tipo de servicio recibido*. En estos casos, el número de observaciones dependerá de la participación efectiva de los usuarios, por lo que no se garantiza un tamaño mínimo para cada categoría.

En síntesis: *la cuota define cuánto se busca captar; el dominio define para quién se quiere producir un resultado.*

- **Variable de calibración.** Corresponde a una variable auxiliar utilizada en el ajuste posterior de los pesos para aproximar la composición de la muestra a totales poblacionales de referencia. Una misma variable puede intervenir tanto en la definición de cuotas como en la calibración, pero cumple una función diferente en cada etapa.

Por ejemplo, sexo puede utilizarse durante la captación para establecer cuotas de participación y posteriormente utilizarse como variable de calibración para ajustar los pesos de la muestra a la distribución poblacional de referencia. En el primer caso, la variable contribuye a determinar cuántas personas se busca captar; en el segundo, contribuye a determinar cómo se ajustan los pesos de las personas que finalmente participaron.

De manera similar, región, régimen, grupo de edad o zona pueden formar parte de la estructura de cuotas y, posteriormente, incorporarse

al procedimiento de calibración, de acuerdo con los totales poblacionales disponibles y la estrategia de ajuste definida.

La variable de calibración, por tanto, responde a la pregunta: *¿contra qué información poblacional se ajustan posteriormente los pesos de las personas que participaron?*

En síntesis, las cuatro nociones cumplen funciones diferentes:

Cuadro 4.7: Diferenciación conceptual entre cuota, estrato, dominio y variable de calibración, ENUS 2026.

Concepto	Función principal	Ejemplo en ENUS 2026
Cuota	Controlar la composición de la captación	Meta para Caribe × Subsidiado × Femenino × 30–39 × Urbano
Estrato	Organizar una selección probabilística dentro de una partición de la población	No corresponde a las celdas de cuota de ENUS 2026
Dominio	Definir un grupo para producir o analizar resultados	Régimen subsidiado, una región o una EPS
Variable de calibración	Ajustar los pesos respecto de totales poblacionales conocidos	Sexo, edad, régimen, región o zona

Esta diferenciación es particularmente importante en la ENUS 2026 porque una misma variable puede aparecer en varias etapas del proceso sin que ello signifique que desempeña la misma función. Por ejemplo, **región** puede utilizarse para establecer una cuota, definir un dominio de análisis y participar posteriormente en la calibración de los pesos. Lo que cambia no es la variable, sino la función que cumple en cada etapa del diseño y del análisis.

4.2.12 Alcance de los análisis por dominio y estructura de la participación

La posibilidad de producir resultados para un dominio determinado dependerá de la participación efectiva de los usuarios que pertenecen a dicho dominio. En consecuencia, la definición de una categoría como dominio potencial de análisis no implica que necesariamente se disponga de un número suficiente de observaciones para producir estimaciones con la precisión o estabilidad requerida.

Esta consideración es particularmente relevante para variables que no hacen parte de las cuotas principales de captación, entre ellas las relacionadas con la EPS, IPS, gestor, tipo de servicio recibido u otras características institucionales. La distribución de participantes en estas categorías dependerá de la participación efectiva de los usuarios y, por tanto, no puede garantizarse mediante el tamaño total de la muestra.

De igual manera, las celdas de cuota no deben interpretarse como garantía de suficiencia analítica para todos los cruces posibles entre variables. A medida que aumenta el nivel de desagregación, el número de observaciones disponibles en cada subgrupo puede disminuir y afectar la estabilidad de los resultados.

Por esta razón, la producción de resultados desagregados deberá considerar, para cada dominio, el número efectivo de observaciones, la distribución de los pesos, la variabilidad de los estimadores y los criterios de calidad estadística definidos para la ENUS 2026. Los resultados correspondientes a dominios con baja participación deberán ser identificados y, cuando corresponda, limitarse a análisis descriptivos o presentarse con las advertencias metodológicas pertinentes.

La interpretación de los resultados también deberá considerar el posible efecto de la autoselección. El sistema de cuotas permite controlar la composición de la muestra respecto de las variables utilizadas para su construcción, pero no elimina necesariamente diferencias entre las personas que participan y aquellas que, aun perteneciendo a la población objetivo, no participan. Estas diferencias pueden presentarse en variables observadas y no observadas y afectar la representatividad de los resultados (Elliott y Valliant 2017; Wang y Valliant 2015; Lee y Valliant 2006).

En consecuencia, la estructura de cuotas debe entenderse como un mecanismo de control de la composición de la captación y no como una garantía de representatividad para cualquier nivel de desagregación. El alcance final de los análisis estará condicionado por la participación efectiva de los usuarios, la composición alcanzada de la muestra y los resultados de los procedimientos posteriores de ponderación y calibración.

Referencias

- Agency for Healthcare Research and Quality. 1995. *Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems (CAHPS)*. <https://www.ahrq.gov/cahps/index.html>.
- Agency for Healthcare Research and Quality. 2024. «CAHPS Measures of Patient Experience». <https://www.ahrq.gov/cahps/consumer-reporting/measures/index.html>.
- Baker, Reg, J. Michael Brick, Nancy A. Bates, et al. 2013. «Summary Report of the AAPOR Task Force on Non-probability Sampling». *Journal of Survey Statistics and Methodology* 1 (2): 90-143.
- Cochran, William G. 1977. *Sampling Techniques*. 3.^a ed. Wiley.
- Consultores en Información Infométrika S.A.S. 2015. *Estudio de Evaluación de los Servicios de las EPS por Parte de los Usuarios, en el Régimen Contributivo y Subsidiado: Informe de Resultados*. Ministerio de Salud y Protección Social. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/estudio-evaluacion-servicios-eps.pdf>.
- Cressie, Noel, y Timothy R. C. Read. 1984. «Multinomial Goodness-of-Fit Tests». *Journal of the Royal Statistical Society. Series B* 46 (3): 440-64.
- Defensoría del Pueblo de Colombia. 2009. *Evaluación de los Servicios de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) desde la Perspectiva del Usuario*. Defensoría del Pueblo de Colombia.
- Deville, Jean-Claude, y Carl-Erik Särndal. 1992. «Calibration Estimators in Survey Sampling». *Journal of the American Statistical Association* 87 (418): 376-82.
- Efron, Bradley, y Robert J. Tibshirani. 1993. *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall/CRC.

Elliott, Michael R., y Richard Valliant. 2017. «Calibration weighting for non-probability samples». *Statistical Science* 32 (2): 249-64.

Kish, Leslie. 1965. *Survey Sampling*. Wiley.

Lee, Sunghee, y Richard Valliant. 2006. *Propensity Score Adjustment for Nonresponse in Surveys*. RTI Press.

Lohr, Sharon L. 2021. *Sampling: Design and Analysis*. 3.^a ed. CRC Press.

Matajira Gaitán, Camilo, Eric Barney Iglesias, Wilman Bonett Molina, y Germán Escobar Morales. 2018. *Sistema de Evaluación y Calificación de Actores: Ranking de Satisfacción EPS 2018*. Oficina de Calidad, Ministerio de Salud y Protección Social. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/ranking-satisfaccion-eps-2018.pdf>.

Ministerio de la Protección Social. 2006. *Decreto 1011 de 2006, por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud*. Ministerio de la Protección Social. https://www.minsalud.gov.co/normatividad_nuevo/decreto/%201011/%20de/%202006.pdf.

Ministerio de la Protección Social. 2008. *PECASUSS: Percepción de Calidad según Usuarios de Servicios de Salud*. Ministerio de la Protección Social.

Ministerio de Salud y Protección Social. 2016a. *Decreto 780 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social*. Ministerio de Salud y Protección Social. <https://www.minsalud.gov.co/Normativa/paginas/decreto-unico-minsalud-780-de-2016.aspx>.

Ministerio de Salud y Protección Social. 2016b. *Encuesta de Evaluación de los Servicios de las EPS: Informe Final*. Oficina de Calidad, Ministerio de Salud y Protección Social. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/evalacion-servicios-eps-2016.pdf>.

Ministerio de Salud y Protección Social. 2016c. *Resolución 256 de 2016, por la cual se dictan disposiciones en relación con el Sistema de Información para la Calidad y se establecen los indicadores para el monitoreo de la calidad en salud*. Ministerio de Salud y Protección Social. <https://minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/abece-resolucion-256-de-2016.pdf>.

Ministerio de Salud y Protección Social. 2017. *Encuesta Nacional de*

Evaluación de los Servicios de las EPS: Informe Final Colombia 2017. Ministerio de Salud y Protección Social. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Informe-encuesta-satisfaccion-eps-2017.pdf>.

Ministerio de Salud y Protección Social. 2020. *Estudio Nacional de Evaluación de los Servicios de las EPS – Régimen Contributivo y Subsidiado 2020: Informe Final.* Oficina de Calidad, Ministerio de Salud y Protección Social. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/evaluacion-eps-2020-minsalud.pdf>.

Ministerio de Salud y Protección Social. 2022. *Encuesta Nacional de Satisfacción de los Usuarios frente a los Servicios de las EPS – 2022.* Ministerio de Salud y Protección Social. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/encuesta-satisfaccion-servicios-eps-2022.pdf>.

Ministerio de Salud y Protección Social. 2023. *Resultados de la Encuesta para Evaluar la Satisfacción de los Usuarios del Sistema de Salud Colombiano con Énfasis en Atención Primaria en Salud.* Ministerio de Salud y Protección Social. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/resultados-encuesta-satisfaccion-usuarios-sistema-salud-colombiano-enfasis-atencion-primaria.pdf>.

Ministerio de Salud y Protección Social. 2024. *Informe de Resultados: Encuesta para Evaluar la Satisfacción de los Usuarios del Sistema de Salud Colombiano 2024.* Oficina de Calidad, Ministerio de Salud y Protección Social. <https://www.sispro.gov.co/observatorios/oncalidadsalud/Paginas/Publicaciones.aspx>.

Ministerio de Salud y Protección Social. 2025. *Encuesta para Evaluar la Satisfacción de los Usuarios del Sistema de Salud Colombiano 2025.* Oficina de Calidad, Ministerio de Salud y Protección Social. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/informe-encuesta-satisfaccion-2025.pdf>.

Ministerio de Salud y Protección Social. 2026. *Resolución 1642 de 2026, por la cual se actualizan las reglas para la elaboración, entrega y divulgación de la Carta de Derechos y Deberes de las personas afiliadas al sistema de salud y se adopta la Encuesta Nacional de Experiencia del Usuario en Salud (ENUS) como instrumento oficial y permanente de medición del desempeño de las EPS y demás actores del sistema.* Ministerio de Salud y Protección Social.

OECD. 2025. *Does Healthcare Deliver? Results from the Patient-Reported Indicator Surveys (PaRIS).* OECD Publishing. <https://www.oecd.org/en/>

[publications/does-healthcare-deliver_c8af05a5-en.html](#).

Rao, J. N. K., y C. F. J. Wu. 1988. «Resampling Inference with Complex Survey Data». *Journal of the American Statistical Association* 83 (401): 231-41.

Wang, Wei, y Richard Valliant. 2015. «Propensity Score Adjustment for Web Surveys». *Journal of Survey Statistics and Methodology* 3 (2): 147-70.

World Health Organization. 2000. *The World Health Report 2000: Health Systems – Improving Performance*. World Health Organization.